

БЕКТЕМ
Кыргыз Республикасынын
Саламаттык сактоо министрлигинин
алдындагы Дары каражаттары жана
медициналык буюмдар
департаментинин директорунун
орун басары
Абдиев М.К.
« 18 » сентябрь 2020-ж.

**ДАРЫ КАРАЖАТЫН МЕДИЦИНАДА КОЛДОНУУ БОЮНЧА
НУСКАМА**

БЕЛАЗИДИМ

Соодадагы аталышы

Белазидим

Эл аралык патенттелбеген аталышы

Цефтазидим

Дарынын түрү

Инъекция үчүн эритмени даярдоого порошок.

Курамы

Ар бир флакон төмөнкүлөрдү камтыйт:

Активдүү зат:

Цефтазидим USP 1 г (цефтазидим пентагидрат түрүндө)

Стерилдүү цефтазидим пентагидраттын жана стерилдүү натрий карбонаттын аралашмасы.

Сүрөттөлөшү

Актан крем сымал түскө чейинки кристаллдык порошок.

Фармадарылык тобу

Системалуу колдонуу үчүн микробго каршы препараттар. Системалуу колдонуу үчүн бактерияга каршы препараттар. Бета-лактамыдык бактерияга каршы башка препараттар. Үчүнчү муундагы цефалоспориндер. Цефтазидим.

АТХ коду: J01DD02.

Фармакологиялык таасири

Фармакодинамикасы

Цефтазидим III муундагы цефалоспориндер тобунун бактерияга каршы препараты болуп саналат, кеңири спектрге ээ жана бактерициддик таасир берет, микроорганизмдердин клеткалык капталынын синтезин бузат, көбүнчө бета-лактамаздын таасирине туруктуу.

Препарат грам терс микроорганизмдерге карата активдүү: *Haemophilus influenzae*, *Neisseria gonorrhoeae* жана башка *Neisseria* spp. жана көбүнчө *Enterobacteriaceae* (*Citrobacter* spp., *Enterobacter* spp., *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae* үй бүлөлөрүнүн өкүлдөрү жана башка *Klebsiella* spp., *Morganella morganii* жана башка *Morganella* spp., *Proteus mirabilis* (ошондой эле Индол оң), *Proteus vulgaris* жана башка *Proteus* spp., *Providencia rettgeri* жана башка *Providencia* spp. жана *Serratia* spp.), *Acinetobacter* spp., *Haemophilus parainfluenzae* (ампициллинге туруктуу штаммдарды кошкондо), *Pasteurella multocida*, *Salmonella* spp., *Shigella* spp. жана *Yersinia enterocolitica*.

Цефтазидим *Pseudomonas aeruginosa* жана оорукана ичиндеги инфекцияларга карата III муундагы цефалоспориндердин арасындагы абдан жогорку активдүүлүккө ээ.

Препарат грам оң бактерияларга карата активдүү: *Micrococcus* spp., *Streptococcus aureus*, *Streptococcus mitis*, *Streptococcus pneumoniae*, *Streptococcus pyogenes* A тобундагы, *Streptococcus viridans* жана башка *Streptococcus* spp. (*Streptococcus faecalis* кошпогондо); метициллинге сезгичтүү штаммдар: *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*.

Цефтазидим анаэробдук бактерияларга карата активдүү:

Bacteroides spp. (көбүнчө штаммдар *Bacterioides fragilis* - туруктуу), *Clostridium perfringens*, *Peptococcus* spp., *Peptostreptococcus* spp. жана *Propionobacterium* spp..

Препарат метициллин туруктуу штаммдарга карата активдүү эмес *Campylobacter* spp., *Chlamydia* spp., *Clostridium difficile*, *Enterococcus* spp., *Listeria monocytogenes* жана башкалар *Listeria* spp., *Staphylococcus aureus* жана *Staphylococcus epidermidis*; *Streptococcus faecalis*.

Фармакокинетикасы:

Куюудан кийин препарат адамдын организмде тез бөлүштүрүлөт жана көбүнчө ткандарда жана суюктуктарда, ошондой эле жүлүн, перикардиялык жана перитонеалдык суюктукка, ошондой эле өткө, какырык жана заарада тез бөлүштүрүлөт. Бөлүштүрүү ошондой эле сөөктөрдө, миокардда, өт баштыкчасында, териде жана инфекциялык ооруларды дарылоо үчүн жетиштүү жумшак ткандарда, өзгөчө препараттын диффузиясын күчөтүүчү сезгенген процесстерде жүрөт. Жабыркабаган гематоэнцефаликалык бөгөттөө аркылуу начар өтөт, бирок препараттын жүүн суюктуган өткөн терапевтикалык деңгээли менингитти дарылоо үчүн жетиштүү.

Плазманын белоктору менен байланышуу кайтарымдуу (15% дан азыраак), бактерициддик таасир менен бир гана бош түрүндө ээ болот. Белоктор менен байланышуу деңгээли концентрациядан көз каранды эмес. 0,5 г же 1 г булчуң ичине куюуда максималдуу концентрация бир сааттан кийин ылайыгына жараша 17 мкг/мл жана 39 мкг/мл га барабар, көк кан тармырга куюуда ылайыгына жараша 42 мкг/мл жана 69 мкг/мл ды түзөт.

Булчуң ичине куюуда максималдуу концентрацияга жетүү убактысы - 1 саат, көк кан тамырга куюуда - инфузиянын аягында 4 мкг/мл га барабар болгон препараттын концентрациясы 6 - 8 саат ичинде сакталат. Кандын плазмасындагы терапевтикалык концентрация 8 - 12 саат ичинде сакталат. Нормалдуу бөйрөк функциясында - 1,8 саат; бузулган - 2,2 саат.

Препарат боордо зат алмашат, боор функциясынын бузулуусу препараттын фармакодинамикасына жана фармакокинетикасына таасир этпейт. Мындай бейтаптардын дозасы адаттагыдай калат.

Бөйрөктөр менен өзгөрүлбөгөн түрдө 80 - 90% (куюулган дозанын 70% биринчи 4 саатта бөлүнүп чыгат) сутканын ичинде клубочкалуу чыпкалоо жана каналчалуу секреция жолу менен бирдей деңгээлде бөлүнүп чыгат. Бөйрөк функциясынын бузулуусунда дозаны төмөндөтүү сунушталат.

Бөлүштүрүү көлөмү 0,21 - 0,28 л/кг ды түзөт. Препарат жумшак ткандарга, бөйрөктөргө, өпкөгө, сөөктөргө жана муундарга, илээшме көндөйлөрдө чогулат.

Колдонууга көрсөтмө

Белазидим микроорганизмдер менен препаратка сезгичтүүлөр менен пайда болгон, төмөнкү инфекциондук ооруларды дарылоо үчүн чоңдорго жана балдарга дайындалат:

- оор инфекциялар: менингит; сепсис (септицемия);
- оор ириндүү-септикалык абал;
- сөөктөрдүн жана муундардын инфекциялары: септикалык артрит, остеомиелит, бактериалдык бурсит;
- дем алуу жолдорунун инфекциялары: курч жана өнөкөт бронхит, инфицирленген бронхоэктазиялар, грам терс бактериялар менен пайда болгон пневмония, өпкөнүн абсцесси, плевранын эмпиемасы;
- заара чыгаруу жолдорунун инфекциялары: курч жана өнөкөт пиелонефрит, пиелит, простатит, цистит, уретрит (бактериалдык гана), бөйрөктүн абсцесси;
- теринин жана жумшак ткандардын инфекциялары: мастит, жаранын инфекциялары, тери жаралары, флегмона, рожа, инфицирленген жаралар;
- АИЖ, ич көндөйүнүн жана өт жолдорунун инфекциялары: перитонит, энтероколит, ичтин абсцесстери, дивертикулит, кичине жамбаш органдарынын сезгенүүсү, холецистит, холангит, өт баштыкчасынын эмпиемасы;
- Аялдардын жыныстык органдарынын инфекциялары;
- Кулактын, тамактын, мурундун инфекциялары: ортоңку отит, синусит, мастоидит жана башкалар;
- гонорея (өзгөчө пенициллиндер тобундагы бактерияга каршы препараттардагы жогорку сезгичтүүлүктө).

Каршы көрсөтмө

- гиперсезгичтүүлүк, ошондой эле башка цефалоспориндерге.

Этияттуулук менен: бөйрөк алсыздыгы, АИЖ ооруусу (ошондой эле таржымалында жара колити), илмектүү диуретиктер менен жана аминогликозиддер менен чогуу бир убакта кабыл алуу, жаңы төрөлгөн мезгил.

Кош бойлуулук жана бала эмизүү мезгили:

Кош бойлуулукта препарат эгерде эне үчүн болжолдонгон пайда түйүлдүк жана бала үчүн потенциалдык кооптууукту ашып түшкөн учурда гана колдонулат. Бала эмизүү мезгилинде препаратты колдонууда баланы эмизүүнү токтотуу керек.

Колдонуу жолу жана дозалары:

Белазидим парентералдык жол менен куюулат – К.Т/И жана Б/И.

Чоңдору жана 12 жаштан жогорку балдарда Белаидим препаратынын адаттагы дозасы ар бир 8-12 саатта 1 г же 12 саат аралык менен 2 г дан.

Ошондой эле оорунун жайылуусу жана оордугу менен аныкталган, куюунун кыскалыгы жана жолу төмөнкү дозалар менен сунушталган:

- заара чыгаруу жолдорунун өрчүп кетпеген инфекцияларында - 0,25 г дан ар бир 12 саатта К.Т/И же Б/И;
- заара чыгаруу жолдорунун өрчүп кеткен инфекцияларында - 0,5 г дан ар бир 8 саатта же 12 саатта К.Т/И же Б/И;
- өрчүп кетпеген пневмонияда, теринин жана жумшак ткандардын инфекцияларында, ЛОР-органдардын инфекцияларында - 0,5-1 г дан ар бир 8 саатта к.т/и же б/и;
- оор интраабдоминалдык же гинекологиялык инфекцияларда - 2 г дан ар бир 8 саатта Б/и;
- сөөктөрдүн жана муундардын инфекцияларында - 2 г дан ар бир 12 саатта К.Т/И;
- бактериалдык менингитте - 2 г дан ар бир 8 саатта К.Т/И;
- оор, жашоого коркунуч алып келген инфекцияларда жана фебрилдүү нейтропенияда - 2 г дан ар бир 8 саатта К.Т/И, же 3 г дан ар бир 12 саатта К.Т/И (максималдуу суткалык доза- 6 г);
- муковисцидоз менен жана бөйрөктүн нормалдуу функциясы менен бейтаптарда *Pseudomonas aeruginosa* пайда болгон оор өпкө инфекцияда - 30-50 мг/кг ар бир 8 саатта К.Т/И.

Эрендик безге операция жасоодо операциядан кийинки өрчүп кетүүлөрдү антибиотикоалдын алуу үчүн операцияга чейин 30 минута мурун Белаидим препаратын К.Т/И 1 г куят, заара катетерин алууда да 1 г Белаидим препаратын куюу сунушталат. 1 айдан жогорку жана 12 жашка чейинки балдарга адатта 30-50 мг/кг дан ар бир 8 саатта куюлат.

Бактериалдык менингитти дарылоо үчүн, ошондой эле иммунодефицит менен же муковисцидоз менен балдардагы инфекцияны дарылоо үчүн, суткалык доза 150 мг/кг ды (бирок 6 г суткасынан жогору эмес) түзөт, бул 3 жолу куюуга бөлүнөт.

Жаңы төрөлгөндөргө (1 айга чейинки балдарда) 30 мг/кг дан ар бир 12 саатта К.Т/И дайындалат.

Бөйрөк функциясынын бузулуусу менен бейтаптарга креатининдин клиренсинин көрсөткүчтөрүнөн улам дозаны жана куюу режимин оңдоп түзөтүү талап кылат. Дарылоо биринчи жүктүү дозалар катарында 1 г Белаидим препаратын куюудан башталат. Кийинкисинде колдоочу режим төмөнкү таблицада көрсөтүлгөндөй эсептелет:

КК, мл/мин	50-31	30-16	15-5	<5
Режим	1 г ар бир 12 саат	1 г ар бир 24 саат	0,5 г ар бир 24 саат	0,5 г ар бир 48 саат

Өнөкөт бөйрөк алсыздыгынын фонунда оор агымдагы инфекциялар менен бейтаптарга таблицада көрсөтүлгөн бир жолку дозаларды 50% га жогорулатууга мүмкүн, же ортосундагы аралыктарды кыскартуу керек. Кийинкисинде, дозалар режимин оңдоп түзөтүү бөлүнүп чыккан микроорганизмдердин сезгичтүүлүк маалыматтарынын негизинде, оорулуунун абалынын оордугуна жана кандын сары суусундагы цефтазидимдин концентрациясына терапевтикалык мониторинг жүргүзүүнүн

маалыматтарына жараша жүргүзүлөт (калдыктуу концентрация 40 мг/л ди ашып кетпеш керек).

Гемодиализде: Жүктүү доза - 1 г, андан кийин гемодиализдин ар бир процедурасынан кийин 1 г дан. артериовеноздук шунтту колдонуу менен үзгүлтүксүз гемодиализде жана жогорку ылдамдыктуу гемофилтрацияда күн сайын – суткасына 1 г (бир же бир нече куюу үчүн). Төмөнкү ылдамдыктагы гемофилтрацияны жүргүзүүдө Белаидимди бөйрөк функциялары бузулууда сунушталган дозаларда дайындалат.

Перитонеалдык диализде башында 1 г (жүктүү доза) куюлат, андан кийин 0,5 г дан ар бир 24 саатта дайындалат. К.Т/И же Б/И куюуга кошумча катары, 2 л диализдүү эритмеге 0,25 г Белаидим препаратын эсептегенде диализдүү эритменин курамында Белаидим препаратын куюу мүмкүн.

Белаидим препаратын куюуну инфекциянын симптомдору жоголгондон кийин дагы 2 күн улантуу керек. Оор жана өрчүп кеткен инфекциянын учурларында дарылоонун узака созулган курстары таап кылынышы мүмкүн.

Белаидим көк кан тамырга (жылжытып, тамчылатып) жана булчуң ичине.

Белаидим препаратын аралаштыруу анча көп эмес экзотермиялык реакция менен коштолот, мында углероддун диоксиди бошонулат жана флакондо оң басым түзүлөт. Углероддун диоксидинин көбүкчөлөрү даяр эритмеге катышышы мүмкүн, бул препараттын натыйжалуулугуна таасир этпейт. Эритменин жеңил сарыга боёлушу ошондой эле натыйжалуулукка таасир этпейт.

Булчуң ичине куюу:

Б/И куюу үчүн Белаидим препаратынын стерилдүү порошогун инъекция үчүн стерилдүү сууга же 0,5-1% лидокаин гидрохлориддин эритмесине аралаштырат (амиддик типтеги жергиликтүү анестетиктерди көтөрө албастыкта көрсөтмөлөрдүн жоктугунда).

Эриткичтин кийинки минималдуу санын антибиотиктин кургак порошогу менен түздөн түз флаконго аралаштырат:

1,0 г Белаидим препаратын камтыган флаконго 3,0 мл стерилдүү сууга.

Алынган эритме, болжол менен 260 мг/мл цефтазидимдин концентрациясын, айкын булчуң катмары менен дененин аймагына булчуң ичине терең куюлат (жамбаштын жогорку ички квадрантына же сандын латералдык үстүңкү бетине). Кан тамырчаларга эритмени терс куюп алуудан алыс болуу үчүн, аспирацияга тест жүргүзүү сунушталат.

Көк кан тамырга куюу:

Белаидимди жылжытып К.Т/И куюу үчүн инъекция үчүн стерилдүү сууга аралаштырат. Эриткичтин кийинки санын антибиотиктин кургак порошогу менен түздөн түз флаконго аралаштырылат: 1,0 г Белаидим препаратын камтыган флакондо 10 мл инъекция үчүн сууга.

Алынган эритме, болжол менен 90 мг/мл цефтазидимдин концентрациясын 3-5 минута ичинде К.Т/И жаай куюлат; эгерде оорулуу Белаидим препараты менен суюктуктарды парентералдык түрдө чогуу кабыл алса, К.Т/И инфузия үчүн инъекция системасына атайын түйүн же порт аркылуу куюу мүмкүн.

Белаидимди тамчылатып К.Т/И куюу үчүн, Б/И тамчылатып куюу үчүн сыяктуу аралаштырылат. Алынган эритмени инфузиондук чөйрөдө сыйымдуу болгон 50-100 мл камтый турган флаконго аралаштырылат. 30 минутадан аз эмес убакыттын ичинде К.Т/И система аркылуу куюлат.

Белаидим 5% декстрозанын эритмеси менен 0,9% натрий хлориддин эритмеси менен, 10% декстрозанын эритмеси менен, 0,225% натрий хлоридди жана 5% декстрозаны камтый

турган суулу эритме менен, 0,45% натрий хлоридди жана 5% декстрозаны камтый турган суулу эритме менен; 0,9% натрий хлоридди жана 5% декстрозаны камтый турган суулу эритме менен; Рингер эритмеси менен; Рингердин лактирленген эритмеси менен; 1/6 М натрий лактаттын эритмеси менен; 10% инверттик канттын эритмеси менен; 5% глюкоза менен «Нормозол-М» эритмеси менен сыйышат.

Кыйыр таасирлер

Аллергиялык реакциялар: бөрү жатыш, чыйрыгуу же калтырак басуу, бөртмө, кычышуу, бронхкарышуусу, эозинофилия, Стивенс-Джонсондун синдрому, токсикалык эпидермалдык некролиз (Лайелла синдрому), ангионевротикалык шишимик, анафилактикалык шок.

Тамак-аш сиңирүү системасы тарабынан: көңүл айнуу, кусуу, ич өтүү, метеоризм, курсактын оорусуу, дисбактериоз, боор трансаминаздын активдүүлүгүн жогорулоосу, ЩФ, гипербилирубинемия, стоматит, глоссит, псевдомембраноздук энтероколит, орофарингеалдык кандидоз, холестаз.

Кан жаратуу системасы тарабынан: эозинофилия, лейкопения, нейтропения, агранулоцитоз, гранулоцитопения, тромбоцитопения, гемолитикалык аз кандуулук, лимфоцитоз, геморрагиялар.

Жыныс системасы тарабынан: кандидоздук вагинит.

Заара бөлүп чыгаруу системасы тарабынан: бөйрөк функциясынын бузулуусу, токсикалык нефропатия.

БНС тарабынан: баш оору, баш айлануу, парестезиялар, баш айлануу, калтырак басып эстен тануулар, энцефалопатия, "титиреген тремор".

Лабораториялык көрсөткүчтөр: гиперкреатининемия, мочевинын концентрациясынын жогорулоосу, глюкозага зааранын жалган оң реакциясы, Кумбстун жалган оң түз реакциясы, протромбиндүү убакыттын жогорулоосу.

Жергиликтүү реакциялар: К.Т/И куюуда - флебит; Б/И куюуда - ооруксунуу, ачышуу, инъекция болгон жердеги калындашуу.

Башкалар: мурундан кан кетүү, суперинфекция.

Ашыкча доза

Симптомдору: ооруксунуу, сезгенүү, инъекция болгон жердеги флебит, баш айлануу, парестезиялар, баш оору, бөйрөк алсыздыгы менен бейтаптарда катырак басуу, гиперкреатининемия, гипербилирубинемия, тромбоцитоз, тромбоцитопения, эозинофилия, лейкопения, протромбиндик убакыттын узаруусу.

Дарылоо: симптоматикалык, бөйрөк алсыздыгы учурларында - перитонеалдык диализ же гемодиализ.

Башка дары каражаттар менен өз ара таасири

Фармацевтикалык жактан аминокликозиддер менен сыйышпайт (маанилүү өз ара инактивация: бир убакта колдонууда бул препараттарды дененин ар түрдүү жерине куюу керек) жана ванкомицин менен (концентрацияга жараша тунмаларды пайда кылат; зарыл болгон учурда эки препараттын бир түтүк аркылуу куюу керек, алдарды колдонуунун ортосунда К.Т/И куюу үчүн системаны жууп тазалоо керек). Натрий гидрокарбонат эритмесин эритүүчү катары колдонууга болбойт (диоксид углероду пайда болот, бул газдын сыртка чыгуусун талап кылышы мүмкүн).

“Илмектүү” диуретиктер, аминогликозиддер, ванкомицин, клиндамицин клиренсин төмөндөтөт, анын натыйжасында нефротоксиндик таасиринин өрчүү коркунучу жогорулайт.

Бактериостатикалык антибиотиктер (анын ичинде хлорамфеникол) препараттын таасирин төмөндөтөт.

Фармацевтикалык жактан төмөнкү эритмелер менен айкалышат: 1 ден 40 мг/мл га чейинки - NaCl 0,9% концентрацияда; натрий лактат; Гартман эритмеси; декстроза 5%; NaCl 0,225% жана декстроза 5%; NaCl 0,45% жана декстроза 5%; NaCl 0,9% жана декстроза 5%; NaCl 0,18% жана декстроза 4%; декстроза 10%; декстран NaCl 0,9% эритмесинде 40 миң. Да 10% га жакын мол.масса менен же 5% декстрозанын эритмесинде; декстран NaCl 0,9% эритмесинде 70 миң. Да 6% жакын мол.масса менен же 5% декстрозанын эритмесинде.

0,05 ден 0,25 мг/мл чейинки концентрацияларда цефтазидим интраперитонеалдык диализ үчүн (лактат) эритмелер менен сыйышат. БИ куюу үчүн цефтазидим 0,5-1% лидокаин гидрохлориддин эритмеси менен аралаштырылышы мүмкүн. Эки курам бөлүк тең активдүүлүктү сактайт, эгерде 4 мг/мл концентрацияда цефтазидим төмөнкү эритмелерге кошулса: гидрокортизон (гидрокортизон натрий фосфаты) 1 мг/мл NaCl 0,9% эритмесинде же 5% декстрозанын эритмесинде; цефуросим (цефуросим натрийи) 3 мг/мл NaCl 0,9% эритмесинде; флоксациллин (флоксациллин натрийи) 4 мг/мл NaCl 0,9% эритмесинде; гепарин 10 ЭБ/мл же 50 ЭБ/мл NaCl 0,9% эритмесинде; KCl 10 мЭк/л же 40 мЭк/л NaCl 0,9% эритмесинде. Цефтазидимдин (500 мг ды 1,5 мл инъекция үчүн сууга) жана метронидазолдун (500 мг/100 мл) эритмесин аралаштырууда эки курам бөлүк тең өзүнүн активдүүлүгүн сактайт.

Өзгөчө көрсөтмөлөр

Пенициллинге таржымалында аллергиялык реакциялары бар бейтаптарда, цефалоспориндүү антибиотиктерге жогорку сезгичтүүлүк ээ болушу мүмкүн. Дарылануу мезгилинде этанолду колдонбоо керек.

Препаратты колдонууда жана дарылоону аяктагандан кийин 2-3 жуманын ичинде *Clostridium difficile* пайда болгон ич өтүүнүн өрчүүсү мүмкүн. Жеңил учурларда дарылоону токтотуу жана ионоалмаштыруучу смолду (колестирамин, колестипол) колдонуу жетиштүү, оор учурларда суюктукту, электролиттерди жана белокторду жоготуунун ордун толтуруу көрсөтүлгөн, ванкомицинди, бацитрацинди же метронидазолду дайындоо. Ичегилердин перистальтикасын токтотуучу дары каражаттарын колдонууга болбойт.

Авто унаа айдоо жана механизмдерди башкаруу жөндөмдүүлүгүнө таасири:

Дарылануу мезгилинде транспорттук каражаттарды башкарууда жана баш айлануунун пайда болуу кооптуулугунан улам психомотордук реакциянын тездигин жана көңүл буруунун жогорку концентрациясын талап кылуучу кыймылдарды башкарууда этияттуулукту сактоо керек.

Чыгаруу формасы

Флакандордо инъекция үчүн эритмени даярдоого порошок.

Бир флакон колдонуу боюнча нускасы менен бирге картон кутуга салынат.

Сактоо шарты

Кургак, жарыктан корголгон, 25°C дан жогору эмес аба табында сактоо керек.

Балдар жетпеген жерде сактоо керек.

Жарактуулук мөөнөтү

3 жыл. Жарактуулук мөөнөтү аяктагандан кийин колдонууга болбойт.

Берүү шарты

Дарыгердин рецепти боюнча.

Каттоо күбөлүгүнүн ээси

Belinda Laboratories LLP

Astra House, Arklow Road,

London, England SE14 6EB, UK (Великобритания)

Өндүрүүчү

Nectar Lifesciences Ltd. (Unit-VI)

Village Bhatoli Kalan (Adjoining Jharmajri E.P.I.P.),

P.O. Barotiwala, Tehsil. Baddi, Disst. Solan,

H.P.-174103, India (Индия)

Кыргыз Республикасынын аймагында продукциянын (товардын) сапаты боюнча арыз-доолорду кабыл алуучу уюмдун дареги:

«Aman Pharm» (Аман Фарм) ЖЧК, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары,

Шооруков көчөсү 36.

Тел.: (0312) 560466, E-mail: aman.pharm12@gmail.com